

Depresión

Guía práctica para tu consulta · TCC + Activación Conductual

CUÁNDO SE UTILIZA

Tristeza persistente, pérdida de interés, fatiga, cambios en sueño/apetito y dificultad de concentración que afectan la vida diaria por más de 2 semanas.

CÓMO EXPLICARLO AL PACIENTE

"La depresión es una condición que afecta la energía, el sueño y el pensamiento — no es culpa tuya ni falta de voluntad. Tu sistema de estrés se quedó encendido y el cuerpo está agotado. Acá vamos a trabajar juntos para regularlo y recuperar movimiento paso a paso."

INTERVENCIONES PASO A PASO

Psicoeducación

01

Explicar el modelo cognitivo: pensamiento → emoción → conducta. Mostrar cómo el aislamiento y la inactividad mantienen la depresión.

Ejemplo: "No te pido que tengas ganas. En la depresión las ganas no vuelven esperando — vuelven moviéndose. Por eso vamos a empezar con algo muy pequeño, aunque no tengas energía."

Activación conductual

02

Identificar actividades que antes daban placer. Programar actividades pequeñas antes de que aparezca el 'ganas'. La acción precede al estado de ánimo.

Ejemplo: "Hoy podés empezar con algo muy breve que antes disfrutabas, como salir a caminar 10 minutos."

Reestructuración cognitiva

03

Identificar pensamientos automáticos negativos (inútil, sin futuro, sin valor). Buscar evidencia y alternativas más realistas.

Ejemplo: "Noté que pensaste 'no sirvo para nada'. ¿Qué evidencia tenés a favor y en contra de eso?"

Rutina y autocuidado

04

Trabajar sueño, actividad física leve y hábitos que apoyen la recuperación. El cuerpo y la mente se regulan juntos.

Ejemplo: "Dormir un poco mejor y tener horarios regulares puede ayudarte a recuperar energía."

Prevención de recaídas

05

Identificar señales de alerta tempranas. Armar un plan de acción ante recaída. Reforzar los avances del proceso.

Ejemplo: "¿Qué señales te avisarían que tu ánimo está bajando? ¿Qué podrías hacer apenas las notes?"

Recuerda:

La depresión tiene tratamiento. La activación conductual es intervención de primera línea con nivel de evidencia A. Con acompañamiento consistente, la recuperación es posible.

Trastornos de ansiedad

Guía práctica para tu consulta · TCC · Exposición · Relajación

CUÁNDO SE UTILIZA

Ansiedad que genera malestar intenso, preocupación excesiva o conductas de evitación que limitan la vida diaria. Incluye TAG, fobia social y fobias específicas.

CÓMO EXPLICARLO AL PACIENTE

"La ansiedad es una respuesta de alarma que intenta protegerte. Vamos a aprender a manejarla para que deje de limitar tu vida."

INTERVENCIONES PASO A PASO

01

Psicoeducación

Explicar el ciclo de la ansiedad: activación → evitación → alivio a corto plazo → mantenimiento. La evitación es el principal combustible del trastorno.

Ejemplo: "La ansiedad sube, tu cuerpo se activa y evitás. Eso alivia un momento, pero mantiene el problema."

02

Identificación de evitación

Mapear las situaciones que evita y las conductas de seguridad que usa. Cuantificar el impacto en su vida cotidiana.

Ejemplo: "¿Qué dejás de hacer por miedo? ¿Qué has notado que sucede cuando te sentís ansioso/a?"

03

Exposición gradual

Construir jerarquía de exposición de menor a mayor dificultad. Enfrentar gradualmente lo que se teme, sin escapar ni usar conductas de seguridad.

Ejemplo: "No empezamos por lo más difícil. Construimos una lista de menor a mayor y arrancamos por algo que te genere poca activación. Paso a paso."

04

Reducción de conductas de seguridad

Disminuir los apoyos que mantienen la ansiedad a largo plazo. El objetivo es que aprenda a tolerar la incomodidad sin muletas.

Ejemplo: "Podés intentarlo sin llevar el papel escrito. ¿Puedes probarlo sin esa ayuda esta vez?"

05

Intolerancia a la incertidumbre (TAG)

Cuestionar la creencia de que la preocupación previene el desastre. Exposición imaginaria a escenarios inciertos.

Ejemplo: "Cambiar 'algo malo va a pasar' por 'puedo manejarlo paso a paso, incluso sin saber cómo termine'."

06

Regulación fisiológica

Respiración diafragmática 4-7-8 o relajación muscular progresiva para bajar la activación. Es un apoyo complementario, no el tratamiento central.

Ejemplo: "Practicar respiración lenta puede ayudarte a bajar la activación. ¿Qué notás cuando la probás?"

Recuerda:

La TCC es el tratamiento de elección para los trastornos de ansiedad (grado A, NICE y OMS). La exposición con prevención de respuesta es su componente más activo.

Pánico

Guía práctica para tu consulta · Modelo de Clark · Exposición interoceptiva

CUÁNDO SE UTILIZA

Crisis de pánico recurrentes con miedo a que se repitan, acompañadas de interpretaciones catastróficas de sensaciones físicas internas.

CÓMO EXPLICARLO AL PACIENTE

"El pánico es una falsa alarma de tu cuerpo. Vamos a aprender a entender esas sensaciones y enfrentarlas de forma segura para que pierdan su poder."

INTERVENCIONES PASO A PASO

01

Modelo cognitivo del pánico

Explicar el ciclo de Clark: sensación física → interpretación catastrófica → más activación → ciclo. El problema no es la sensación, sino la interpretación.

Ejemplo: "Siento palpitaciones y pienso que me voy a desmayar. ¿Qué otra explicación puede haber?"

02

Registro del ciclo

Hacer consciente el ciclo: qué sensación apareció, qué pensé, qué hice. Romper la automaticidad.

Ejemplo: "¿Qué sensación apareció primero? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste después?"

03

Exposición interoceptiva

Inducir deliberadamente las sensaciones físicas temidas para demostrar que son tolerables y no peligrosas. Ejercicios: girar, respirar rápido, saltar.

Ejemplo: "Vamos a girar en una silla para producir mareo y ver que baja solo. ¿Qué notaste?"

04

Exposición situacional

Enfrentar los lugares o situaciones evitadas por miedo a que desencadenen el pánico.

Ejemplo: "Esta semana intentá entrar al supermercado y quedarte hasta que notes que la ansiedad empieza a bajar sola. No hace falta que desaparezca, solo que baje un poco."

05

Reducción de escape y reaseguro

Disminuir conductas que mantienen el miedo: salir corriendo, llamar al médico, revisar el pulso constantemente.

Ejemplo: "La ansiedad siempre llega a un techo y baja. El objetivo es que puedas observar ese proceso sin salir de la situación antes de que eso ocurra."

Recuerda:

El trastorno de pánico tiene tasa de remisión del 70-90% con TCC. La exposición interoceptiva es la técnica más específica y diferenciadora de este protocolo.

TOC

Guía práctica para tu consulta · EPR: Exposición con Prevención de Respuesta

CUÁNDO SE UTILIZA

Pensamientos intrusivos que generan ansiedad intensa y llevan a realizar rituales o compulsiones para neutralizarla.

CÓMO EXPLICARLO AL PACIENTE

"El TOC no es manía ni falta de voluntad. Es un ciclo que podemos entender y trabajar para que pierda fuerza."

INTERVENCIONES PASO A PASO

01

Psicoeducación del ciclo

Explicar el ciclo obsesivo-compulsivo: pensamiento → ansiedad → ritual → alivio → refuerzo. El ritual es lo que mantiene el problema vivo.

Ejemplo: "Tenés un pensamiento que molesta, hacés un ritual para calmarte. El alivio dura poco y el ciclo vuelve."

02

Mapeo del ciclo completo

Identificar todos los pensamientos, rituales, situaciones desencadenantes y conductas de evitación. Construir jerarquía de dificultad.

Ejemplo: "¿Qué pensamiento apareció? ¿Cuánta ansiedad sentiste (0-10)? ¿Qué hiciste para bajarla?"

03

EPR — Exposición con Prevención de Respuesta

Exponerse al estímulo temido y NO realizar el ritual hasta que la ansiedad baje sola. Es la intervención de mayor evidencia para TOC.

Ejemplo: "Vamos a tocar la manija y esperar sin lavarte las manos. Podemos tolerar la ansiedad sin hacer el ritual."

04

Reestructuración cognitiva

Cuestionar la sobrestimación de amenaza, la responsabilidad inflada y la intolerancia a la incertidumbre típicas del TOC.

Ejemplo: "¿Qué tan probable es realmente que ocurra lo que temés? ¿Qué evidencia tenés a favor y en contra?"

05

Prevención de recaídas

Armar un plan personalizado con señales de alerta y qué hacer ante ellas. El TOC puede reactivarse en períodos de estrés.

Ejemplo: "Identifiquemos señales de alerta y qué podés hacer para seguir practicando sin volver al ciclo."

Recuerda:

La EPR es el tratamiento psicológico con mayor evidencia para el TOC (nivel A). La práctica constante debilita el ciclo y fortalece la confianza del paciente.

PTSD / Trauma

Guía práctica para tu consulta · TCC-T · EMDR · Fases del tratamiento

CUÁNDO SE UTILIZA

Después de un evento traumático: reexperimentación (flashbacks, pesadillas), evitación, hipervigilancia y alteraciones cognitivas que siguen afectando la vida cotidiana.

CÓMO EXPLICARLO AL PACIENTE

"El trauma puede dejar huellas. Vamos a trabajar para que recuperes seguridad, calma y confianza en tu propio cuerpo y en el mundo."

INTERVENCIONES PASO A PASO

01

Psicoeducación del trauma

El cuerpo sigue en modo alerta porque aprendió que el peligro existe. La reacción es normal ante un evento anormal. No hay nada 'roto'.

Ejemplo: "Tu cuerpo sigue en modo alerta porque intenta protegerte. Podemos enseñarle que ya estás a salvo."

02

Estabilización y regulación (FASE 1)

PRIMERO: establecer seguridad física y emocional. Herramientas de regulación: respiración, grounding 5-4-3-2-1, lugar seguro imaginario. No procesar trauma en esta fase.

Ejemplo: "Probemos una respiración para bajar la intensidad y volver al aquí y ahora cuando te sentís desbordada."

03

Procesamiento del recuerdo (FASE 2)

Abordaje gradual del recuerdo: TCC centrada en trauma (CPT), exposición prolongada o EMDR. Siempre a ritmo del paciente, con tolerancia a la activación.

Ejemplo: "Vamos a hablar de lo ocurrido a tu ritmo, para que puedas integrarlo sin que te abrume."

04

Reestructuración cognitiva del trauma

Trabajar creencias de culpa, peligro permanente y desconfianza generalizadas. El trauma distorsiona la lectura del mundo presente.

Ejemplo: "Lo que pasó no fue tu culpa. Exploremos otras formas de entender lo ocurrido sin que ese recuerdo defina quién sos hoy."

05

Reconexión y proyecto de vida (FASE 3)

Fortalecer recursos, relaciones y perspectiva de futuro. Integrar el trauma sin que siga siendo el centro de la identidad.

Ejemplo: "Paso a paso podés volver a sentir confianza y construir una vida con sentido más allá de lo que te pasó."

Recuerda:

El trauma se trabaja en FASES. Nunca procesar en una persona desestabilizada. Estabilización ANTES de procesamiento. La recuperación es posible.